

ΡΙΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ

Γενικά: Η ρινική συμφόρηση χαρακτηρίζεται από αδυναμία αναπνοής - λόγω έμφραξης της μύτης - ρινική έκκριση, πταρμό και υποσμία (κόρυζα - Hay fever). Οφείλεται στο γεγονός ότι η αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων του ρινικού βλεννογόνου προκαλεί τη συλλογή οροβλεννώδους υγρού τοπικά, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των ρινικών εκκρίσεων. Μπορεί να είναι λοιμώδης, αλλεργική, περιβαλλοντική (υγρασία, ρύπανση), ορμονική, κ.λπ.

Ιστορικό: Εξετάζουμε αν πρόκειται για φλεγμονώδους ή αλλεργικής αιτιολογίας, ρινίτιδα. Οικογενειακό ιστορικό και ιστορικό επαφής με ζώα ή επαγγελματικής έκθεσης σε ουσίες.

Ελέγχουμε για ύπαρξη συνοδών σημείων ή συμπτωμάτων: πυρετός ή δέκατα, δακρύρροια, κνησμός, πταρμός, επιπεφυκίτιδα, μαύροι κύκλοι στα μάτια («αλλεργικά φωτοστέφανα»), ερεθιστικός βήχας, διαταραχές της ευσταχιακής σάλπιγγας, ατοπική δερματίτιδα, κ.ά.

Στην **Αλλεργική Ρινίτιδα** η ρινική συμφόρηση συνήθως διαρκεί περισσότερο από τα άλλα συμπτώματα και συνήθως θεραπεύεται δυσκολότερα από τους πταρμούς, τη ρινόρροια και τον κνησμό. Τούτο, οφείλεται στο γεγονός, ότι η αλλεργική ρινική συμφόρηση προκαλείται με τη μεσολάβηση αρκετών χημικών μεσολαβητών (IgE, IL-4, IL-5, TSLP, IL-25, IL-33). Σημειώνεται ότι χρονίως αλλεργικοί ασθενείς φέρουν συχνά μακριές βλεφαρίδες στα μάτια.

Διαφορική διάγνωση: Χρόνια ιγμορίτιδα, ρινικοί πολύποδες ή νεόπλασμα, αγγειοκινητική ρινίτιδα, αντιδραστική ρινίτιδα κατάκλισης, κοκκιωματώδεις νόσοι (Wegener), ξένο σώμα στη μύτη, σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. **ΑΝΤΙΪΣΤΑΜΙΝΙΚΑ** [Σε οξεία έξαρση, δίδονται δις ημερησίως, υπό ιατρική καθοδήγηση].

- Δεσλοραταδίνη: tab. 5 mg (syr. 0,5 mg/ml) *Aerius / Rinispes*, 1x1, προ φαγητού, ή
- Λεβοσετιριζίνη: tab. 5 mg (syr. 0,5 mg/ml) *Xozal / Contrahist*, 1x1, προ φαγητού, ή
- Βιλαστίνη: tab. *Bilaz / Bilargen* 20 mg, 1x1, περίπου 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά φαγητού.

Η χορήγηση αντιϊσταμινικών - τοπικά ή συστηματικά - θεωρείται λιγότερο αποτελεσματική στη ρινική συμφόρηση, ενώ κρίνεται αρκετά αποτελεσματική για τα άλλα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας, τα οποία προκαλούνται κυρίως από την έκλυση ισταμίνης (π.χ. κνησμός, πταρμός, ρινόρροια).

2. **ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ** [χορηγούνται για μικρό χρονικό διάστημα (7-10 ημέρες)].

- Ρινικό εκνέφωμα Οξυμεταζολίνης (*Ronal*), 1-2 ψεκασμοί ανά ρώθωνα, ανά 8-12 ώρες.
- Εναλλακτικά, Ξυλομεταζολίνη (*Otrivin*), ρινική ενστάλαξη 3 σταγόνων, ανά 8-12 ώρες.

Τα φάρμακα αυτά δεν μπορούν να χορηγηθούν πέραν των 7-10 ημερών, διότι δημιουργούν φαινόμενα εξάρτησης ή δημιουργία φαρμακευτικής ρινίτιδας, γεγονός που σημαίνει ότι για να «ξεμπορκώσει» η συμπεφορημένη μύτη πρέπει να ψεκάσει μόνο με το τοπικό αποσυμφορητικό. Η μακροχρόνια χρήση τοπικών αποσυμφορητικών ενδέχεται να βλάψει το βλεννοκροσσωτό επιθήλιο της ρινικής κοιλότητας.

3. **ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ** [για μικρό διάστημα (7-10 ημέρες), πλην ορισμένων εξαιρέσεων].

- ▶ Ρινικό εκνέφωμα Μομεταζόνης (*Nasonex*): 1-2 ψεκασμοί ανά ρώθωνα, άπαξ ημερησίως.
- ▶ Ρινικό εκνέφωμα Τριαμσινολόνης (*Nasatrim*): 2 ψεκασμοί ανά ρώθωνα, άπαξ ημερησίως.
- ▶ Εναλλακτικά, χορηγούνται συνδυασμοί κορτικοστεροειδών/αποσυμφορητικών, δηλαδή: Δεξαμεθαζόνη + Τραμαζολίνη (*Dexarhina*) ή Φλουτικαζόνη + Αζελαστίνη (*Dymista*):
 - Nasal sus. *Dexarhina*, 2 ψεκασμοί ανά ρώθωνα, κάθε 8-12 ώρες, μόνο για 5-10 ημέρες.
 - Nasal sus. *Dymista*, 2 ψεκασμοί ανά ρώθωνα, κάθε 12 ώρες, ακόμα και για 1-2 μήνες.

4. Σε συνύπαρξη βήχα ή δύσπνοιας χορηγείται Μοντελουκάστη (*Modulair* 10 mg), καθώς και συμπτωματική αγωγή για τα συνοδά συμπτώματα (π.χ. φαρυγγαλγία, πυρετός, κ.λπ.).

5. Επανάλεγχος μετά από 5-7 ημέρες. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, παραπέμπουμε για:

- ▶ Ακτινογραφία παραρρινίων κόλπων, για διερεύνηση πιθανής παραρρινοκολπίτιδας.
- ▶ Αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, CRP, ανοσολογικό προφίλ, ολική IgE ορού).
- ▶ Καλλιέργεια πτυέλων και επιχρίσματος φάρυγγα. Αλλεργικές δοκιμασίες στο δέρμα.